

内分泌 · 昼夜节律

褪黑素水平分析

Melatonin Testing

参考收费

¥507 元 / 项

睡不好只是表象——褪黑素是昼夜节律的夜间信号，一次抽血看清节律的内分泌基础。

样本 血清 2mL | 分离胶促凝管，冷藏 2 天

注意 采血时间必须记录 · 报告 4-5 个工作日

1 临床意义

褪黑素是身体「该睡觉了」的信号——天黑后开始上升，凌晨 2-3 点最高。它不够，入睡和睡眠深度就容易出问题。熬夜、夜班、睡前刷手机都会把它压下去；但光看症状分不清是不是它的原因，抽一次血就知道。

2 适合人群 以下情况建议了解本项目

- 长期入睡困难、睡眠浅、易醒或早醒
- 习惯睡前长时间使用手机、电脑
- 已在服用褪黑素，想知道该不该吃、吃多少
- 关注抗氧化与整体节律状态
- 夜班工作者、经常倒班
- 白天精神不振、注意力难集中
- 长期服用 β 受体阻滞剂等可能影响分泌的药物
- 经常跨时区出行或有时差困扰
- 50 岁以上，关注睡眠质量与节律变化
- 有焦虑、抑郁情绪并伴睡眠问题

3 报告模板 检测结果的呈现方式

检测结果 示例数据

实际数值以检验报告为准

检测项目	结果	参考区间 (pg/mL)	水平定位	判读
褪黑素 MT	<1.0	白天 2.0 – 80.0 晚上 18.5 – 180.0	本例 偏低 ↓ 参考区间内 偏高 ↑	偏低 ↓

示例是上午 09:09 抽的血，对照白天区间。抽血时间决定用哪套区间，一定要记准。

偏低 ↓

常见于熬夜、夜班、夜间光照过度，或年龄自然下降。

参考区间内

水平正常，保持现有作息即可。

偏高 ↑

多数是自己在吃褪黑素补充剂。

4 与相关检查的区别

睡眠量表 PSQI

问的是「你觉得睡得好不好」，本项目查的是「为什么」。

多导睡眠监测 PSG

查打鼾、呼吸暂停的**金标准**，不测激素。

褪黑素节律分析

唾液多点采样，看的是节律**时相**有没有错位；本项目看的是**水平够不够**。

5 可以做什么 结果异常时的干预方向

光照与作息 对表

光是生物钟的对表信号：白天见强光把节律调准调强，夜里见光则直接压住分泌。**关键是白天亮、夜里暗的反差**——反差越大，夜间分泌越足、越准时。

白天多晒太阳（尤其上午）；睡前 1 小时不看屏幕；固定起床时间。

饮食 原料

褪黑素由色氨酸转化而来，原料不足产量上不去；酒精与咖啡因会干扰分泌。

牛奶、鸡蛋、鱼、豆类等含色氨酸的食物。

营养补充 助力

B 族维生素与镁是这条转化路径上酶的帮手；直接补褪黑素则是补成品。

偏低可**遵医嘱**补充，不建议自行加量。

以上调整**持续 2-3 个月后可复查**，看数值有没有回升——这是判断干预是否起效最直接的方式。

6 常见问题

直接买褪黑素吃不就行了？

补过量反而压制自身分泌。先测，才知道要不要补、补多少。

要抽血吗？空腹吗？

要抽一次静脉血，不需空腹。但**采血时间要记录**，白天和晚上对照的区间不同。

检测前要注意什么？

正常规律作息 2-3 天再来。前一晚别熬夜、别喝酒、别长时间刷屏。

科学依据

- 褪黑素是国际公认的**昼夜节律标志物**——评估节律相位的金标准方法「昏暗光下褪黑素起始分泌时间（DLMO）」，测的就是褪黑素。
- 美国睡眠医学会（AASM）昼夜节律睡眠觉醒障碍临床实践指南中，褪黑素的给药时点即以 **DLMO 为参照**确定。
- 国际上褪黑素检测主要用于节律障碍的专科评估与研究，**不属于常规体检项目**。本项目为单点血清定量，与 DLMO 的多点控光采样不同，定位为**辅助评估**。

本资料为检测项目说明，不构成医疗建议；检测结果需由医师结合临床综合判断。文中数值为示例，仅用于说明报告结构。

内分泌 · 压力与性腺轴

压力与性激素平衡评估
(男)

Stress & Sex Hormone Balance

参考收费

¥540 元 / 项

累、没状态、提不起劲——是压力太大，还是雄激素掉了？一次抽血分清楚。

样本 血清 2mL | 分离胶促凝管，冷藏 2 天

注意 建议 8:00-9:00 采血 · 报告 10-11 个工作日

1 临床意义

人在长期压力下，肾上腺会持续分泌**皮质醇**。皮质醇和性激素共用同一条原料通路，压力一大，身体优先造皮质醇，性激素就被挤占。「累、没状态、提不起劲」常常不是错觉，而是这条轴已经失衡——这个检测把压力激素和性激素放在一起看，判断失衡到了哪一步。

2 报告模板 检测结果的呈现方式

检测结果 示例数据

实际数值以检验报告为准

检测项目	结果	参考区间	单位
压力激素			
皮质醇 (COR)	6.95×10 ⁴	8 a.m. (0.4-2.2)×10 ⁵	pg/mL
雄激素			
睾酮 (T)	4150.1	2400 - 9500	pg/mL
脱氢表雄酮 (DHEA)	2229.90	< 10000	pg/mL

皮质醇有明显昼夜节律，上午与下午对照不同区间，采血时间必须记录。示例为上午采血。

3 适合人群 以下情况建议了解本项目

- 长期高压工作、经常加班或熬夜
- 情绪低落、易怒，注意力下降
- 睡眠质量差、夜间易醒
- 正在或考虑激素补充，需要基线数据
- 疲劳感持续，休息后不缓解
- 肌肉量下降、腹部脂肪增加
- 40 岁以上，关注雄激素水平变化
- 性欲减退、晨勃减少
- 运动表现或恢复能力明显下滑
- 备孕人群，需评估生殖内分泌状态

4 与相关检查的区别

普通性激素六项

多为化学发光法的常规组合，本项目用**质谱法**并把压力激素一并纳入。

肾上腺皮质压力管理与评估

唾液多点采样，看皮质醇**一天的节律曲线**；本项目看的是单点水平与性激素的关系。

甲功、血糖等常规项

查的是其他轴的功能，与本项目互补，不能互相替代。

5 可以做什么 结果异常时的干预方向

压力与睡眠 源头

皮质醇由压力驱动，长期高位会持续挤占性激素的原料。**不减压力，单补性激素往往效果有限。**

规律作息、控制加班强度；正念、呼吸训练等已有证据的减压方式。

运动 调节

规律的中等强度运动能改善皮质醇节律与胰岛素敏感性；但**过量高强度训练反而抬高皮质醇**，方向会反过来。

每周 3-5 次中等强度有氧，配合抗阻训练；避免长期过度训练。

营养 原料

性激素以胆固醇为原料，长期极低脂饮食会限制合成；蛋白质与微量元素参与酶促环节。

保证优质蛋白与健康脂肪摄入；**不建议自行使用激素类补剂。**

调整**持续 3 个月后可复查**，重点看皮质醇是否回落、性激素是否回升。

6 常见问题

跟普通的性激素六项有什么区别？

本项目把**压力激素皮质醇**和雄激素放在一起看，能判断是压力挤占还是性腺本身的问题。

要空腹吗？什么时候来抽？

不需空腹，但**建议上午 8:00-9:00 采血**——皮质醇此时处于峰值，参考区间也是按这个时段设的。

在吃睾酮或保健品，能测吗？

可以测，但**务必主动告知**。外源补充会直接影响数值，不说清楚结果没法判读。

科学依据

- 1 皮质醇是应激反应的核心效应激素，其**昼夜节律**（晨峰夜谷）是内分泌学的基本认识，报告按上午/下午分设参考区间即基于此。
- 2 本项目采用**质谱法**测定，相比免疫法在低浓度区间与结构类似的甾体激素间的特异性更好。
- 3 本项目为**单时点血清**检测，不等同于皮质醇节律评估（需多点采样）；结果用于功能医学与健康管理场景的辅助评估，不作为内分泌疾病的诊断依据。

本资料为检测项目说明，不构成医疗建议；检测结果需由医师结合临床综合判断。文中数值为示例，仅用于说明报告结构。

内分泌 · 压力与性腺轴

压力与性激素平衡评估
(女)

Stress & Sex Hormone Balance

参考收费

¥710 元 / 项

总是累、情绪起伏大、月经不规律——先看压力激素有没有挤占性激素。

样本 血清 2mL | 分离胶促凝管，冷藏 2 天

注意 建议 8:00-9:00 采血 · 报告 10-11 个工作日

1 临床意义

人在长期压力下，肾上腺会持续分泌**皮质醇**。皮质醇和性激素共用同一条原料通路，压力一大，身体优先造皮质醇，性激素就被挤占。「累、没状态、提不起劲」常常不是错觉，而是这条轴已经失衡——这个检测把压力激素和性激素放在一起看，判断失衡到了哪一步。

2 报告模板 检测结果的呈现方式

检测结果 示例数据

实际数值以检验报告为准

检测项目	结果	参考区间	单位
压力激素			
皮质醇 (COR)	1.07×10 ⁵	8 a.m. (0.4-2.2)×10 ⁵	pg/mL
脱氢表雄酮 (DHEA)	2569.53	< 8000	pg/mL
垂体激素 按月经周期分设区间			
促卵泡刺激素 (FSH)	5.88	卵泡中期 3.85~8.78 绝经后 16.74~113.59	mIU/mL
促黄体生成素 (LH)	5.15	卵泡中期 2.12~10.89 绝经后 10.87~58.64	mIU/mL
卵巢激素			
雌二醇 (E2)	32.4	绝经前 15-350 绝经后 <10	pg/mL
孕酮 (P4)	4126.4	卵泡期≤2700 黄体期3000-31400	pg/mL

皮质醇有明显昼夜节律，上午与下午对照不同区间，采血时间必须记录。FSH、LH、雌二醇、孕酮的区间按月经周期分设，采血时须说明末次月经日期。

3 适合人群 以下情况建议了解本项目

- 长期高压工作、经常加班或熬夜
- 经前情绪波动大、乳房胀痛
- 体重变化明显、腹部脂肪增加
- 正在或考虑激素补充，需要基线数据
- 疲劳感持续，休息后不缓解
- 情绪低落、易怒、睡眠变差
- 围绝经期，想了解激素变化
- 月经周期不规律、经量变化明显
- 痤疮、多毛或脱发等雄激素相关表现
- 备孕前想评估内分泌状态

4 与相关检查的区别

普通性激素六项

多为化学发光法的常规组合，本项目用**质谱法**并把压力激素一并纳入。

肾上腺皮质压力管理与评估

唾液多点采样，看皮质醇**一天的节律曲线**；本项目看的是单点水平与性激素的关系。

甲功、血糖等常规项

查的是其他轴的功能，与本项目互补，不能互相替代。

5 可以做什么 结果异常时的干预方向

压力与睡眠 源头

皮质醇由压力驱动，长期高位会持续挤占性激素的原料。**不减压力，单补性激素往往效果有限。**

规律作息、控制加班强度；正念、呼吸训练等已有证据的减压方式。

运动 调节

规律的中等强度运动能改善皮质醇节律与胰岛素敏感性；但**过量高强度训练反而抬高皮质醇**，方向会反过来。

每周 3-5 次中等强度有氧，配合抗阻训练；避免长期过度训练。

营养 原料

性激素以胆固醇为原料，长期极低脂饮食会限制合成；蛋白质与微量元素参与酶促环节。

保证优质蛋白与健康脂肪摄入；**不建议自行使用激素类补剂。**

调整持续 3 个月后可复查，重点看皮质醇是否回落、性激素是否回升。

6 常见问题

跟妇科查的性激素六项一样吗？

不一样。妇科多在周期特定时点查基础激素；本项目把**压力激素**纳入，看的是压力与卵巢功能的相互影响。

月经期间能测吗？

可以，但**必须告知末次月经日期**——FSH、LH、雌二醇、孕酮的区间按卵泡中期/周期中期/黄体中期/绝经后分设。

已经绝经了还有必要测吗？

有。四项性激素区间**均设绝经后档**，可评估肾上腺来源的雄激素与压力激素状态。

科学依据

- 皮质醇是应激反应的核心效应激素，其**昼夜节律**（晨峰夜谷）是内分泌学的基本认识，报告按上午/下午分设参考区间即基于此。
- 本项目采用**质谱法**测定，相比免疫法在低浓度区间与结构类似的甾体激素间的特异性更好。
- 本项目为**单时点血清检测**，不等同于皮质醇节律评估（需多点采样）；结果用于功能医学与健康管理场景的辅助评估，不作为内分泌疾病的诊断依据。

本资料为检测项目说明，不构成医疗建议；检测结果需由医师结合临床综合判断。文中数值为示例，仅用于说明报告结构。

内分泌 · 肾上腺节律

肾上腺皮质压力管理与评估

Adrenal Stress Profile

参考收费

¥1318 元 / 项

不是查「压力大不大」，而是查压力激素一天的曲线还正不正常。

样本 唾液 1mL | 唾液采集管，冷冻 14 天

注意 一天四个时点采样 · 方法学 LC-MS/MS

1 临床意义

皮质醇正常的样子是早上冲到高峰、白天逐渐下降、夜里降到低谷——这条曲线让人白天有劲、夜里能睡。长期高压之下，曲线会变形：早上冲不起来（起床困难、整天没劲），或者晚上降不下去（躺下睡不着）。**单次抽血看不出曲线，只有一天多点采样才行。**

2 报告模板 检测结果的呈现方式

检测结果 示例数据

实际数值以检验报告为准

检测项目	结果	参考区间	单位
皮质醇节律 唾液四时点采样			
皮质醇 (F) 7 a.m. – 9 a.m.	1.17 ↓	3.7 - 9.5	µg/L
皮质醇 (F) 11 a.m. – 1 p.m.	1.49	1.2 - 3.0	µg/L
皮质醇 (F) 3 p.m. – 5 p.m.	1.41	0.6 - 1.9	µg/L
皮质醇 (F) 9 p.m. – 11 p.m.	0.234 ↓	0.4 - 1.0	µg/L
肾上腺储备			
脱氢表雄酮 (DHEA)	152.1	71 - 640	ng/L
DHEA / F 比值 ×1000	130	35.5 - 192.7	—

示例的晨峰只有 1.17（下限 3.7）——早上该冲高时候没冲起来，而白天两个时点尚在区间内。**判读看的是这条曲线的形状，不是单个数值。**

3 适合人群 以下情况建议了解本项目

- 起床困难、上午提不起劲，晚上反而精神
- 长期高压、连续加班或轮班工作
- 疲劳持续数月，常规体检又查不出问题
- 睡眠浅、易醒，伴情绪低落
- 反复感冒、感染后恢复慢
- 情绪波动大、易紧张焦虑
- 血糖或血压波动，怀疑与压力相关
- 运动后恢复变慢、易受伤
- 已知压力大，想了解肾上腺功能储备
- 做过压力与性激素评估，需补充节律角度

4 与相关检查的区别

血清皮质醇（单次抽血）

只是曲线上的一个点，且抽血本身会引起应激；本项目用唾液，不受采血应激干扰。

压力与性激素平衡评估

血清单点，同时看性激素；本项目专注**皮质醇一天的节律形状**。

心理量表（如 PSS）

测的是主观压力感受，本项目测的是**身体的实际应答**。

5 可以做什么 结果异常时的干预方向

节律重建 对表

皮质醇节律与光照、进食、活动时间强绑定。**固定起床时间是最有力的锚点**，比强行早睡更有效。

固定起床与三餐时间；上午见光；晚上避免强光与剧烈运动。

负荷管理 减压

皮质醇由压力驱动，工作强度与恢复时间的比例决定曲线能不能回正。

把连续高压时段拆开；保证每周有完整的恢复日。

营养支持 助力

长期应激会加速 B 族维生素、镁、维生素 C 的消耗，这些又是激素合成与神经传导的辅因子。

均衡饮食为主；**补剂需遵医嘱**，不建议自行使用肾上腺类保健品。

干预**3 个月**后**建议复查**，重点看晨峰是否回升、夜间是否回落——曲线形状比单点数值更有意义。

6 常见问题

为什么要采四次唾液？

皮质醇一天里变化很大，**单点看不出曲线**。四个时点才能判断是晨峰不足还是夜间不降。

唾液怎么采？在家能做吗？

用专用采集管，按规定时点各采一次。**采样前 30 分钟不进食、不刷牙、不喝饮料**。

和抽血查皮质醇比，哪个准？

两者测的东西不同。唾液测的是**游离皮质醇**（有生物活性的部分），且不受抽血应激影响。

科学依据

- 1 皮质醇的**晨峰-夜谷昼夜节律**是内分泌学的基本共识，节律形态异常与慢性应激、睡眠障碍及代谢紊乱的关联已有大量研究。
- 2 **唾液皮质醇**反映的是游离（有活性）部分，且采样无创、不引起采血应激，是节律评估中常用的样本类型。
- 3 本项目用于功能医学与健康管理场景下的**节律形态评估**，**不用于诊断库欣综合征、艾迪生病等肾上腺疾病**——这些需内分泌专科按规范流程确诊。

本资料为检测项目说明，不构成医疗建议；检测结果需由医师结合临床综合判断。文中数值为示例，仅用于说明报告结构。

内分泌 • 全谱激素

全套男性荷尔蒙健康评估

Comprehensive Male Hormone Panel

参考收费

¥2574 元 / 项

从垂体到性腺再到肾上腺，一次看完整条激素链——包含 PSA 两项。

样本 血清 4mL | 分离胶促凝管，冷藏 2 天

注意 方法学 LC-MS/MS + 化学发光 • 报告 10-11 个工作日

1 临床意义

激素不是各管各的，而是一条**从上到下的链条**：下丘脑发令、垂体传令、性腺执行，肾上腺在旁边分走原料。链条上任何一环出问题，表现出来的都是「累、情绪差、状态下滑」。只查两三项看不出是哪一环——本项目一次覆盖垂体、性腺、肾上腺与生长轴。

2 报告模板 检测结果的呈现方式

检测结果 示例数据

实际数值以检验报告为准

检测项目	结果	参考区间	单位
垂体激素			
促黄体生成素 (LH)	5.96	1.24 ~ 8.62	mIU/mL
促卵泡刺激素 (FSH)	15.58	1.27 ~ 19.26	mIU/mL
性激素			
雌酮 (E1)	23.7	10 - 60	pg/mL
雌二醇 (E2)	18.9	10 - 40	pg/mL
睾酮 (T)	4856.5	2400 - 9500	pg/mL
游离睾酮 (FT)	66.0	46.0 - 224.0	pg/mL
双氢睾酮 (DHT)	360	112 - 955	pg/mL
雄烯二酮 (AD)	530.8	400 - 1500	pg/mL
脱氢表雄酮 (DHEA)	3432.02	< 5000	pg/mL
孕前激素与肾上腺			
孕烯醇酮 (P5)	201 ↓	220 - 2370	pg/mL
17-羟孕烯醇酮 (17-OHP5)	703.9	550 - 4550	pg/mL
17-羟孕酮 (17-OHP4)	610.9	< 2200	pg/mL
皮质酮 (CORT)	717.7	530 - 15600	pg/mL
皮质醇 (COR)	5.25×10 ⁴	8 a.m. (0.4-2.2)×10 ⁵	pg/mL
结合蛋白与生长轴			
性激素结合球蛋白 (SHBG)	35.7	20.6 - 76.7	nmol/L
胰岛素样生长因子 I (IGF-1)	113.0	69.2 - 226.0	ng/mL
IGF 结合蛋白 3 (IGFBP3)	2.21 ↓	3.10 - 6.43	µg/mL
前列腺			
总前列腺特异性抗原 (t-PSA)	2.500	≤ 4.100	ng/mL
游离前列腺特异性抗原 (f-PSA)	0.455	≤ 0.930	ng/mL

皮质醇按上午/下午对照不同区间。

3 适合人群 以下情况建议了解本项目

- 40 岁以上，关注雄激素与整体状态
- 腹部脂肪增加、体型改变明显
- 有骨密度下降或骨质疏松风险
- 有代谢综合征、糖尿病等内分泌相关问题
- 长期疲劳、性欲减退、肌肉量下降
- 已查过性激素六项但结果解释不清
- 备孕人群，需系统评估生殖内分泌
- 情绪、睡眠与体能同时下滑
- 关注前列腺健康（本项目含 PSA 两项）
- 正在或考虑激素替代，需要基线数据

4 与相关检查的区别

性激素六项

只覆盖链条的一小段，**看不出是垂体、性腺还是肾上腺的问题。**

压力与性激素平衡评估

3 项核心指标的精简版，价格低、周期短；本项目是全谱版本。

PSA 单项检测

只查前列腺，本项目把 PSA 放在全身激素背景下一起看。

5 可以做什么 结果异常时的干预方向

先定位环节 读图

报告按**垂体 → 性腺 → 肾上腺 → 生长轴**分组排列，异常项集中在哪一组，问题大概率就在那一环。

先看分组，再看单项；不要孤立解读某一个数值。

生活方式 基础

睡眠、体重、运动、酒精对多条轴同时起作用，是性价比最高的干预入口。

规律作息、控制体脂、限制酒精；避免长期极低脂饮食。

专科衔接 分流

全谱结果常涉及多个轴，单一科室未必能完整解读。

建议携报告至内分泌科或相应专科，结合症状与既往史综合判断。

激素受周期、应激、药物影响较大，**单次异常不宜直接下结论**；必要时按医嘱复查确认。

6 常见问题

跟性激素六项差在哪？

六项只覆盖一小段。本项目从垂体、性腺一直到肾上腺与生长轴，**能定位到是哪一环。**

包含 PSA 吗？

包含总 PSA 与游离 PSA。但**PSA 异常不等于患癌**，需泌尿外科结合触诊与影像判断。

为什么这么贵？

指标数量多，且多数用**质谱法**测定，成本远高于常规免疫法组合。

科学依据

- 本项目覆盖**下丘脑-垂体-性腺轴**与肾上腺、生长轴的主要激素，分组方式与内分泌学的轴系框架一致。
- 甾体激素采用**质谱法（LC-MS/MS）**测定，在低浓度区间及结构类似物的区分上优于单纯免疫法；部分蛋白类激素采用化学发光法。
- 本项目为**单时点血清检测**，结果受采血时间、月经周期、应激与用药影响，用于健康管理场景的辅助评估，**不作为内分泌疾病的诊断依据。**

本资料为检测项目说明，不构成医疗建议；检测结果需由医师结合临床综合判断。文中数值为示例，仅用于说明报告结构。

内分泌 · 全谱激素

全套女性荷尔蒙健康评估

Comprehensive Female Hormone Panel

参考收费

¥2574 元 / 项

从垂体到卵巢再到肾上腺，一次看完整条激素链——雌、孕、雄激素全覆盖。

样本 血清 4mL | 分离胶促凝管，冷藏 2 天

注意 方法学 LC-MS/MS + 化学发光 · 报告 10-11 个工作日

1 临床意义

激素不是各管各的，而是一条**从上到下的链条**：下丘脑发令、垂体传令、性腺执行，肾上腺在旁边分走原料。链条上任何一环出问题，表现出来的都是「累、情绪差、状态下滑」。只查两三项看不出是哪一环——本项目一次覆盖垂体、性腺、肾上腺与生长轴。

2 报告模板 检测结果的呈现方式

检测结果 示例数据

实际数值以检验报告为准

检测项目	结果	参考区间	单位
垂体激素			
促黄体生成素 (LH)	—	按周期分设	mIU/mL
促卵泡刺激素 (FSH)	—	按周期分设	mIU/mL
雌激素			
雌酮 (E1)	31.8	绝经前 17-200 绝经后 7-40	pg/mL
雌二醇 (E2)	27.7	绝经前 15-350 绝经后 <10	pg/mL
雌三醇 (E3)	—	以报告为准	pg/mL
雄激素			
睾酮 (T)	<80.0 ↓	80 - 600	pg/mL
游离睾酮 (FT)	0.8	≤ 5.0	pg/mL
雄烯二酮 (AD)	364.7	300 - 2000	pg/mL
脱氢表雄酮 (DHEA)	2514.76	< 8000	pg/mL
孕激素与肾上腺			
孕烯醇酮 (P5)	<200 ↓	220 - 2370	pg/mL
17-羟孕烯醇酮 (17-OHP5)	371.7	310 - 4550	pg/mL
17-羟孕酮 (17-OHP4)	172.6	卵泡期<800 黄体期<2850	pg/mL
孕酮 (P4)	<100.0	卵泡期≤2700 黄体期3000-31400	pg/mL
皮质酮 (CORT)	1003.4	530 - 15600	pg/mL
皮质醇 (COR)	7.37×10 ⁴	8 a.m. (0.4-2.2)×10 ⁵	pg/mL
性激素结合球蛋白 (SHBG)	78.9	28.3 - 134.0	nmol/L
生长轴			
胰岛素样生长因子 I (IGF-1)	87.3	84.1 - 258.0	ng/mL
IGF 结合蛋白 3 (IGFBP3)	2.45 ↓	3.35 - 6.78	µg/mL

皮质醇按上午/下午对照不同区间；雌激素、孕酮按月经周期或绝经状态分设区间，采血时须说明。

3 适合人群 以下情况建议了解本项目

- 月经周期紊乱、经量变化明显
 - 多毛、痤疮、脱发等雄激素相关表现
 - 已查过性激素六项但结果解释不清
 - 有多囊卵巢、甲状腺等内分泌相关病史
- 围绝经期，想系统了解激素变化
 - 体重明显变化或腹部脂肪增加
 - 有骨密度下降或骨质疏松风险
- 长期疲劳、情绪波动、睡眠变差
 - 备孕前想评估内分泌基础
 - 正在或考虑激素补充治疗，需要基线数据

4 与相关检查的区别

性激素六项

只覆盖链条的一小段，**看不出是垂体、性腺还是肾上腺的问题。**

压力与性激素平衡评估

3项核心指标的精简版，价格低、周期短；本项目是全谱版本。

AMH（卵巢储备）

评估的是卵泡储备，本项目不含该项，两者用途不同。

5 可以做什么 结果异常时的干预方向

先定位环节 读图

报告按**垂体 → 性腺 → 肾上腺 → 生长轴**分组排列，异常项集中在哪一组，问题大概率就在那一环。

先看分组，再看单项；不要孤立解读某一个数值。

生活方式 基础

睡眠、体重、运动、酒精对多条轴同时起作用，是性价比最高的干预入口。

规律作息、控制体脂、限制酒精；避免长期极低脂饮食。

专科衔接 分流

全谱结果常涉及多个轴，单一科室未必能完整解读。

建议携报告至内分泌科或相应专科，结合症状与既往史综合判断。

激素受周期、应激、药物影响较大，**单次异常不宜直接下结论**；必要时按医嘱复查确认。

6 常见问题

要在月经第几天抽血？

请先咨询医生确定时点。雌激素、孕酮、17-羟孕酮的区间按卵泡期/黄体期/绝经后分设，时点不对无法判读。

绝经了还有必要做吗？

有。雌激素区间**分绝经前后**，且雄激素、肾上腺与生长轴指标不受绝经影响。

跟妇科的性激素六项冲突吗？

不冲突，是**包含关系**。本项目覆盖面更广，可作为六项之外的补充评估。

科学依据

- 1 本项目覆盖**下丘脑-垂体-性腺轴**与肾上腺、生长轴的主要激素，分组方式与内分泌学的轴系框架一致。

2 甾体激素采用**质谱法（LC-MS/MS）**测定，在低浓度区间及结构类似物的区分上优于单纯免疫法；部分蛋白类激素采用化学发光法。

3 本项目为**单时点血清检测**，结果受采血时间、月经周期、应激与用药影响，用于健康管理场景的辅助评估，**不作为内分泌疾病的诊断依据**。

本资料为检测项目说明，不构成医疗建议；检测结果需由医师结合临床综合判断。文中数值为示例，仅用于说明报告结构。